

Otitis media crónica y colesteatoma

1. Introducción y relevancia clínica

La **otitis media crónica (OMC)** corresponde a la **inflamación persistente del oído medio**, caracterizada por **otorragia o secreción ótica crónica**, **perforación timpánica permanente** y, en algunos casos, **pérdida auditiva conductiva o mixta**.

Se considera “crónica” cuando persisten síntomas o secreción por **más de 6 semanas**, o hay evidencia anatómica de daño estructural.

Dentro de la OMC, se distinguen dos formas principales:

1. **Otitis media crónica simple (no colesteatomatosa):**
 - Perforación timpánica estable, otorrea intermitente o ausente, sin destrucción ósea.
2. **Otitis media crónica colesteatomatosa (con colesteatoma):**
 - Presencia de **epitelio escamoso queratinizante** dentro del oído medio o mastoides, que **erosiona estructuras óseas**, pudiendo causar **complicaciones graves intracraneanas o intratemporales**.

Relevancia clínica

- Es una de las **principales causas de hipoacusia adquirida** en países en desarrollo.
- En Chile, aún se observan casos en población rural o con limitaciones de acceso sanitario.
- El **colesteatoma** requiere diagnóstico y tratamiento quirúrgico precoz, ya que puede progresar a **laberintitis, meningitis o absceso cerebral**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Otitis media crónica simple

Se desarrolla como **secuela de otitis media agudas repetidas o mal tratadas**.

El proceso inflamatorio persistente mantiene una **perforación timpánica**, alterando la protección y ventilación del oído medio.

Esto favorece la colonización bacteriana y la acumulación de detritos, perpetuando la infección.

Mecanismos clave:

- Disfunción crónica de la trompa de Eustaquio.
- Colonización bacteriana persistente (biofilm).
- Destrucción mucosa y fibrosis timpánica.

Gérmenes frecuentes:

- *Pseudomonas aeruginosa* (más común).
- *Staphylococcus aureus*.
- *Proteus mirabilis*.
- *Klebsiella spp.*
- *Anaerobios* en casos prolongados.

2.2 Colesteatoma

El **colestomatoma** no es un tumor, sino una **lesión destructiva compuesta por epitelio escamoso queratinizado** que crece anormalmente dentro del oído medio o mastoides.

Origen fisiopatológico:

1. **Invaginación (retractiva):** retracción del cuadrante posterosuperior del tímpano (pars flácida) por presión negativa crónica → se forma un “bolsillo retráctil” que acumula queratina.
2. **Migración epitelial:** epitelio del CAE o del tímpano migra hacia el oído medio a través de una perforación marginal.
3. **Metaplasia o implantación (postraumática o postquirúrgica).**

El colesteatoma **erosiona estructuras óseas** (cadena osicular, pared mastoidea, canal del nervio facial, laberinto) mediante **presión y acción de enzimas proteolíticas** (colagenasas, lisozimas).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

Síntoma	Características
Otorrea crónica o intermitente	Seropurulenta, fétida, persistente pese a tratamiento.
Hipoacusia conductiva	Por destrucción timpano-ossicular.
Sensación de plenitud o oído tapado	Constante o fluctuante.
Tinnitus	Frecuente en OMC avanzada.
Vértigo o inestabilidad	Sugiere erosión laberíntica (colesteatoma).
Otalgia leve o ausente	Dolor aparece solo en complicaciones.

En niños, la manifestación puede ser **supuración crónica indolora** con **disminución auditiva progresiva**.

3.2 Signos clínicos

Oído medio crónico simple

- **Perforación timpánica central** (no marginal).

- Otorrea mucopurulenta, intermitente, no fétida.
- Mucosa del oído medio inflamada o granulada.
- Tímpano atrófico o esclerosado.

Colesteatoma

- **Perforación marginal o retracción posterosuperior** con material blanquecino-queratínico.
- Olor fétido característico.
- Otorrea crónica refractaria a tratamiento.
- Puede observarse **masa perlada** detrás del tímpano.
- Signos de erosión ósea: exposición de cadena osicular o canal facial.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Otitis media crónica simple	Secreción no fétida, perforación central, sin erosión ósea
Otitis externa crónica	Dolor, eritema del CAE, tímpano indemne
Otitis media colestomatosa	Olor fétido, masa blanquecina, perforación marginal
Otitis media serosa	Sin otorrea, tímpano retraído o con burbujas
Tumor glómico o paraganglioma	Masa rojiza pulsátil en oído medio, tinnitus pulsátil

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Criterios clínicos

- Otorrea crónica (>6 semanas).
 - Perforación timpánica persistente.
 - Hipoacusia conductiva.
 - Otorrea fétida o refractaria → sospecha de colesteatoma.
-

4.2 Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Otoscopia / Microscopia	Visualiza perforación, retracción o detritos perlados.
Audiometría tonal	Hipoacusia conductiva o mixta (según erosión).
TAC de peñasco sin contraste	Evalúa extensión, erosión ósea y compromiso mastoideo. Fundamental en colesteatoma.
RM cerebral con difusión (DWI)	Diferencia colesteatoma de tejido inflamatorio.
Cultivo de secreción	En casos con otorrea persistente para ajustar antibióticos.

Diagnóstico confirmado:

Visualización de **masa blanquecina queratínica** en oído medio o mastoides + confirmación imagenológica (TAC o RM).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Objetivos terapéuticos

- Eliminar la infección crónica.
 - Erradicar tejido inflamatorio o colestomatoso.
 - Secar el oído (otitis media “seca”).
 - Restaurar la audición (si es posible).
 - Prevenir complicaciones.
-

5.2 Tratamiento médico (etapa inicial o paliativa)

Solo en OMC simple sin colestoma:

- **Aseo auricular + gotas antibióticas tópicas:**
 - Ciprofloxacino ótico o neomicina/polimixina (7–10 días).
- **Evitar agua en el oído.**
- **Antibióticos sistémicos (amoxicilina-clavulánico o ciprofloxacino VO)** solo en exacerbaciones agudas o mastoiditis incipiente.
- **Corticoides tópicos** (betametasona) en inflamación severa del CAE.

El tratamiento médico controla la infección, pero no corrige la perforación.

5.3 Tratamiento quirúrgico

A. OMC simple

Timpanoplastia (reparación del tímpano y cadena osicular):

- Indicada en perforaciones secas >3 meses, sin infección activa.
- Técnicas: miringoplastia (solo membrana) o timpanoplastia tipo I–IV (según compromiso ossicular).

B. OMC colestomatosa

Cirugía otológica mayor (mastoidectomía):

- **Mastoidectomía cerrada (canal wall up):** conserva pared posterior del CAE.
- **Mastoidectomía abierta (canal wall down):** reseca pared posterior para evitar recurrencia.
- **Objetivo:** erradicar el colesteatoma y preservar audición.

Posteriormente:

- Puede requerirse **cirugía reconstructiva (ossiculoplastía)** para restaurar la audición.

5.4 Seguimiento

- Controles periódicos con otoscopía y audiometría.
- Evitar exposición al agua.
- Revisiones anuales incluso tras cirugía, ya que el colesteatoma puede **recidir** (10–20%).
- En colesteatomas extensos, RM con difusión anual durante 3 años.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Consecuencias
Hipoacusia conductiva o mixta	Erosión ossicular	Reversible tras cirugía si hay reconstrucción
Labirintitis	Extensión al oído interno	Vértigo y sordera irreversible

Parálisis facial periférica	Erosión del canal del VII par	Déficit motor facial
Mastoiditis crónica	Extensión del proceso inflamatorio	Dolor retroauricular, absceso
Complicaciones intracraneanas	Meningitis, absceso cerebral, trombosis seno sigmoideo	Emergencia vital
Recidiva del colesteatoma	Crecimiento residual	Control imagenológico prolongado

Pronóstico:

- Excelente en OMC simple tratada con timpanoplastía (éxito 85–90%).
- En colesteatoma, depende de la extensión y daño ossicular; recurrencia en 15–20%.
- Sin tratamiento, puede evolucionar a hipoacusia irreversible o complicaciones intracraneanas graves.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Otorrea crónica fétida + masa blanquecina retráctil = colesteatoma** hasta demostrar lo contrario.
2. **Pseudomonas aeruginosa** es el germen más común en OMC.
3. En **adulto con OMC unilateral**, descartar **colesteatoma** mediante TAC.
4. La **cirugía es el tratamiento curativo**, no los antibióticos.
5. Toda **OMC con vértigo o parálisis facial** requiere **derivación urgente a ORL**.
6. Tras timpanoplastía, evitar vuelos o inmersiones hasta cierre completo.

Errores comunes

- Usar antibióticos sistémicos repetidos sin limpiar el oído.
 - Irrigar oído con perforación timpánica (riesgo de laberintitis).
 - No realizar TAC en sospecha de colesteatoma.
 - No indicar cirugía en OMC persistente.
 - No advertir sobre el riesgo de complicaciones intracraneanas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **otitis media crónica (OMC)** es una inflamación persistente del oído medio con **perforación timpánica y otorrea crónica**.
2. El **colesteatoma** es una lesión epitelial destructiva que **erosiona el hueso temporal**.
3. El germen más frecuente es **Pseudomonas aeruginosa**.
4. El **diagnóstico** se basa en otoscopía, audiometría y **TAC de peñasco**.
5. El **tratamiento médico** controla la infección, pero la **cirugía** es curativa.
6. Complicaciones graves incluyen **laberintitis, meningitis y absceso cerebral**.
7. Todo paciente con **otorrea fétida o perforación marginal** debe ser **derivado a ORL**.